

Pr Olivier Scatton (CHU Pitié-Salpêtrière,
Paris)

Pr Laurent Siproudhis (CHU Pontchaillou,
Rennes)

Dr Edouard Vaucel (CHU Nantes)

Dr Nicolas Vinit (CHU Necker, Paris)

Dr Mathilde Wagner (CHU Pitié-Salpêtrière,
Paris)

Dr Jean-David Zeitoun (CHU Saint-Antoine,
Paris)

Tuméfaction pelvienne chez la femme

Dr Clémentine Mazoyer¹, Dr Edouard Vaucel², Pr Paul-Antoine Lehur¹

¹Clinique Chirurgicale Digestive et Endocrinienne, CHU de Nantes

²Service de Gynécologie Obstétrique, CHU de Nantes

OBJECTIFS : N° 44. TUMÉFACTION PELVIENNE CHEZ LA FEMME

→ Connaître les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.

- | | |
|--|---|
| 1. Rappels anatomiques | 3.3. Examens paracliniques |
| 2. Principales étiologies et cadres nosologiques | 3.4. Exemples de stratégie et conduites à tenir pratiques |
| 2.1. Obstétricales | 3.4.1. Situations évidentes |
| 2.2. Gynécologiques | 3.4.2. Fibrome |
| 2.3. Digestives | 3.4.3. Tumeur de l'ovaire présumée bénigne |
| 2.4. Urologiques | 3.4.4. Cancer de l'ovaire |
| 2.5. Péritoine et autres espaces pelviens | 3.4.5. Cancer de l'utérus |
| 3. Examen et points importants | 4. Exemple d'arbre décisionnel |
| 3.1. Interrogatoire | 5. Conclusion |
| 3.2. Examen clinique | |

Rang	Rubrique	Intitulé	Descriptif
A	Étiologies	Connaître les 2 étiologies les plus fréquentes de tuméfaction pelvienne	Fibrome utérin et kyste de l'ovaire
A	Étiologies	Connaître les autres causes de tuméfaction pelvienne	Tubaire, digestive, péritonéale
B	Prévalence, épidémiologie	Fréquence des fibromes et des kystes ovariens bénins	
A	Diagnostic positif	Connaître les symptômes et les éléments de l'examen clinique liés aux fibromes	Eléments d'orientation clinique (hémorragies, douleurs, compression, infertilité)
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principales complications des fibromes	
B	Étiologies	Kyste ovarien (KO)	
A	Diagnostic positif	Connaître les symptômes et les éléments de l'examen clinique liés aux kystes ovariens	Eléments d'orientation clinique
A	Étiologies	Savoir différencier kystes fonctionnel et organique	
B	Suivi et/ou pronostic	Connaître les principales complications des kystes ovariens	Torsion, hémorragie, rupture, compression
A	Identifier une urgence	Savoir évoquer une torsion d'annexe	

B	Examens complémentaires	Connaître les 2 principaux examens radiologiques complémentaires à réaliser en cas de tuméfaction pelvienne et leur hiérarchisation (1 ^e - 2 ^e intention)	Échographie et IRM
A	Définition	Définir le prolapsus génital de la femme	
B	Définition	Définir les différents compartiments du prolapsus	Cystocèle, hystérocèle ou prolapsus utérin, rectocèle, élytrocèle
B	Diagnostic positif	Citer les diagnostics différentiels du prolapsus génital de la femme	
B	Prévalence, épidémiologie	Connaître la fréquence du prolapsus	Beaucoup de prolapsus sont non symptomatiques
A	Diagnostic positif	Connaître les signes cliniques du prolapsus	Savoir que les signes associés génito-urinaires et sexuels ne sont pas spécifiques du prolapsus génital. Savoir que le prolapsus génital n'est a priori pas douloureux



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

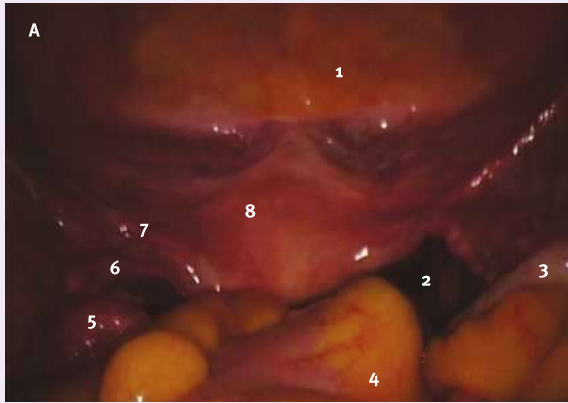
CONFÉRENCES DE CONSENSUS

- Guide HAS ALD n°30, cancer de l'ovaire, janvier 2010 ; cancer invasif du col de l'utérus, janvier 2010
- Fibromes utérins, actualisation de la prise en charge, CNGOF décembre 2011
- Cancer de l'endomètre, synthèse des recommandations, INCA novembre 2010
- Recommandations pour la pratique clinique : les tumeurs de l'ovaire présumées bénignes, CNGOF, décembre 2013
- Colombo N, Creutzberg C, Amant F, et al. ESMO-ESGO-ESTRO Endometrial Consensus Conference Working Group. ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference on Endometrial Cancer: Diagnosis, Treatment and Follow-up. Int J Gynecol Cancer 2016 JAN;26(1):2-30
- Cariou de Vergie L, Venara A, Duchalais E, Frampas E, Lehur PA. Procidence interne du rectum: Définition, évaluation et prise en charge en 2016. J Visc Surg 2017;154:21-28

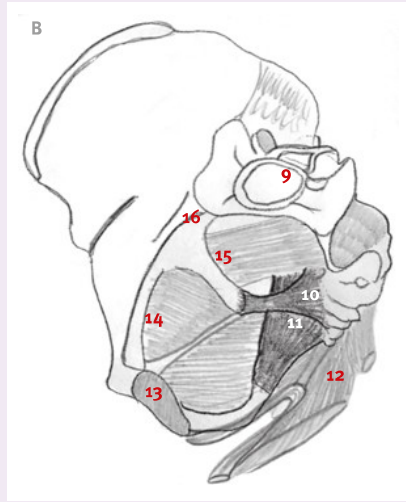
A 1. Rappels anatomiques

- Le pelvis féminin contient les organes génitaux, le bas appareil urinaire, le rectum et le canal anal. Ses limites sont :
 - *supérieure*: le détroit supérieur défini par le rebord supérieur du pubis, les lignes arquées des os coxaux, et le bord antérieur des ailes du sacrum et le promontoire. Le détroit supérieur marque la limite entre grand et petit bassin ;
 - *latérales*: la partie inférieure des os coxaux, les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral, et les muscles obturateur interne et piriforme qui ont leurs origines dans le pelvis et sortent par les foramens ischiatiques ;
 - *inférieure*: le diaphragme pelvien séparant la cavité pelvienne du périnée. Il est constitué des muscles élévateurs de l'anus et ischio-coccygiens. Il présente dans le plan sagittal médian, le hiatus urogénital en avant et le hiatus anal en arrière.

Figure 1. Pelvis féminin normal, vue coelioscopique (A), limites du pelvis (B).



(1) Vessie (relief du ballonnet de la sonde urinaire visible), (2) cul-de-sac de Douglas, (3) appendice, (4) côlon sigmoïde, (5) pédicule vasculaire gonadique, (6) trompe de Fallope et ovaire, (7) ligament rond, (8) Utérus.



(9) Promontoire, (10) ligaments sacro-épineux sacro tubéral, (11) ligament sacro-tubéral (12) diaphragme pelvien, (13) pubis, (14) muscle obturateur interne, (15) muscle piriforme, (16) ligne arquée de l'os coxal.

A 2. Principales étiologies et cadres nosologiques

2.1. Obstétricales

- Grossesse normale.
- Grossesse extra-utérine (cf. **item 25**).
- Complication obstétricale : rétention intra-utérine (ex. post-FCS...), môle hydatiforme, tumeur trophoblastique (cf. **item 24**).

2.2. Gynécologiques

- **Utérus** : tumeur :
 - bénigne : fibrome : cf. diagnostic et classification (importance du TV : masse solidaire de l'utérus, sauf pour les fibromes sous-séreux pédiculés) ;
 - maligne : adénocarcinome de l'endomètre, carcinome épidermoïde du col utérin, sarcome utérin.
- **Ovaires** : kystes ou tumeurs de l'ovaire présumées bénignes :
 - fonctionnel ;
 - organique :
 - bénin : kyste dermoïde, endométriosique ;
 - malin : cancer de l'ovaire (cf. **item 306**).
- **Trompe** : infection utéro-annexielle abcédée, hydrosalpinx, kyste paratubaire.
- **Actinomycose pelvienne** (contexte : DIU depuis plusieurs années).
- **Hématocolpos** (rétention vaginale du sang menstruel par imperforation hyménéale – adolescente).

2.3. Digestives

- **Tumeur** :
 - cancer colorectal, sigmoïdien ;